



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متكرر

إسم المريض ربيعاً : رباب صبحي علي غازي
المحافظة : القاهرة
الحى / المدينة : الزيتون
رقم البطاقة : 28110280101821 رقم التليفون : 01212738572
العنوان : ممم
العمر (تاريخ الميلاد) : 28-10-1981 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 03-10-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإحصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] قسم العلاج : الاورام

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم: د/محمد كيلاني
الاسم: د/ندى حسن
الاسم: د/نرمين رمضان
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
الوظيفة: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
التوقيع: -----
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بان البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /أ.د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي : -----
خطة العلاج : -----
المستشفى : -----
قسم : -----
جهة العلاج : -----
نفقات : -----
ملاحظات : -----

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: رباب صبحي علي غازي National ID: 28110280101821	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد أنه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





MDT FORM

28/03/2022

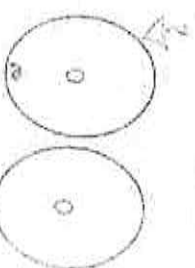
Name	Sajida Bibi		MRN	3191203
Age	40		ID	CA111CA111
Menopausal status			Phone	9999999999
OCP			Marital status	Married
Co morbidity	/		Family history	

Clinical Data

Bx: ID C111 with DXTs R-L B-C

ER: -ve PR: -ve HER2: 3+ Ki67: 3+

Sonography: RT Lower Central Suspicious lesion with IPB in moderate lymph node



Mets Workup: CT -> 3rd line Sclerotic patch Bone scan -> Free

Recommendations:

for upfront surgery BCS + SLNB + post-EC. cc/la. PT, NM (Bos)

MDT OUTCOME & PLAN

12 week wait / 1 yr Monitor DOCT

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	SIGNATURE	RADIOLOGY	PATHOLOGY
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

MS/ru Angelika DOR-Hy 19/03/2022 17:15/1012

Presidential Initiative for Women's Health - Pathology Lab
المبادرة الوطنية لصحة المرأة - معمل الباثولوجي

12/10/2022
Patient Name : الأخت / رباب حبيبي علي غاري
Patient No. : 28110280101821
Path No. :
Sex : Female
Age : 40 Y
Refereing Doc :

Request No. : 13005546
Request Date : 05/04/2022
Verification Date : 12/04/2022
Financial Category : فئة المرضى - Out Patient
Department :
Registered by : marwa mohamed youss

Pathology Report

Clinical Data:
Right breast mass.

Nature of the specimen:
WLE & SLN biopsy & extra superficial margin biopsy.

Gross Examination:

Three specimens were received:

- 1- WLE specimen measured 5x4x2cm.
- Tumor extent: An irregular greyish white hard mass, measured 2.5x2x1.5cm.
- Distance from margins: Least superficial margin was involved grossly.
- 2- Extra superficial margin specimen: Two fibrofatty tissue pieces measured 3.5x2x2cm & 2x1x1cm. Cut section was unremarkable.
- 3- SLN biopsy specimen contained 3 LN, up to 2x1.5cm.
- Frozen section: Free SLN (0/3) & Free margins.

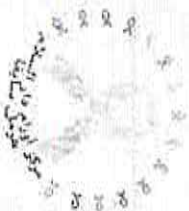
Microscopic examination:

- Histological type: Invasive duct carcinoma.
- Grade (differentiation+ nuclear pleomorphism + mitosis): G3 (3+3+2) ✓
- Angiolinvasion:
- Ductal carcinoma in situ: DCIS 10% with lobular cancerization.
- Lymph node involvement: All SLN were free (0/3).
- Resection Margins: Free all margins.
- Additional pathologic findings: No perineural invasion. No lymphovascular tumour emboli.

Diagnosis:

Right breast mass; WLE & SLN:
-Invasive duct carcinoma grade III, with DCIS 10%

Verified by :
abdelrahmen ibrahim



Name: Rabab Sobhy Ali

Date: 25-1-2022

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN & PELVIS REVEALED:-**

1. Chest:

- Right breast, LIQ irregular parenchymal mass is seen measuring 2.3 x 1.9 cm
- No sizable pulmonary masses, areas of consolidation or cavitary lesions.
- No pathological hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion.
- Normal cardiac size. No pericardial effusion detected.
- Normal CT appearance of the thoracic aorta and the great vessels.

2. Abdomen and pelvis:

- The liver is enlarged with homogenous low CT texture. No focal lesions or contour irregularities.
- Patent homogeneously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
- No intra-hepatic or extra-hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal size & parenchymal texture of the spleen with no focal lesions seen.
- Normal size, parenchymal thickness & density of both kidneys with no stones or back-pressure changes.
- Normal appearance of the pancreas, aorta, I.V.C and both suprarenals.
- Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticula outpouching.
- Normal appearance of the other pelvic organs.
- No abdominal or pelvic lymphadenopathy or collections.
- Left iliac bone, sclerotic osseous patch is seen measuring about 2.2 x 1 cm

OPINION:

- Right breast parenchymal mass.
- No pulmonary or hepatic metastatic deposits.
- Left iliac bone, sclerotic osseous patch for bone scan correlation.

Dr. Peter Nashaat, MSc

Dr. Amr Farouk, MSc

Reda Mousafa

NASSER INSTITUTE

ONCOLOGY CENTER

NUCLEAR MEDICINE UNIT



مركز ناصر
الأورام
وحدة الطب النووي

Patient Name: Rabab Sobhy Ali

Date: 17/3/2022

Tc-99m MDP bone scan.

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions.

Technique:

Delayed Anterior and posterior whole body scan 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc -MDP.

Delayed Static Phase:-

- Degenerative changes are noticed over dorsal and lumbar vertebrae.
- Arthritic changes at knees and shoulders.
- No serious bone lesions detected.
- Both kidneys are seen.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Sherien Mahdy, MD

Huda Fathy, M.D

شماره ثبت: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره پروانه: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰
شماره کارت: ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۸/۱۹
ساعت: ۱۰:۰۰
نام بیمار: ...
نام پزشک: ...

Echo report

Name:

دکتر محمد علی

MIR:

۲۰۰۰

Date: ۱۹/۰۸/۱۴۰۳

EF	68%	55-75%	PWT	3.9	
LVEDD	4.5	3.5-5.8cm	AO.R	2.5	2-3.7cm
LVEDS		2-4cm	LA	3.9	2-4cm
FS		25-45%	RV		0.7-2.3cm(supine)
SWT	3.8	0.6-1.1cm	AO.CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions

normal

LV wall thickness

normal

LV diastolic function

DD grade I

SWMA

no seen

LA and Aortic root dimensions

normal

Mitral Valve

normal

Aortic valve

normal

Tricuspid valve

normal

Pulmonary valve

normal

Right side and systolic function

normal

Intracardiac masses and effusion

no

Dr.

Normal LV internal

dimensi- and systolic D/

Msc cardiology

function 68%

DD grade I

15/8/13